

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	nº 03	nº 26	01 à 05
Nome do procedimento: Prevenção de contato				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Todos os profissionais que prestam assistência direta ao usuário, ou profissionais que realizam atividades junto aos usuários				
Objetivo: Reduzir os riscos à saúde ocupacional e à saúde do usuário				
Recursos necessários: • Pia com água para lavagem de mãos; • Dispenser de sabão; • Dispenser de papel toalha; • Sabonete ou detergente líquidos; • Papel toalha; • Álcool 70%; • Lixeira com pedal para descarte de material comum; • Lixeira com pedal para descarte de material infectante; • Caixa de descarte para material perfuro cortantes; • Equipamento individual de proteção: avental descartável, máscara cirúrgica, luva de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, calçado fechado.				

INDICAÇÃO

Infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimidos (Figura 01). O usuário deve permanecer em leito isolado, ou quarto privativo, sendo que, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de no mínimo um metro.



Figura 01 – Precaução de Contato

Precaução de Contato



Higienização das mãos



Avental



Luvas



Quarto privativo

■ **Indicações:** infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc.

■ Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

■ Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.

■ Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.



Ministério
da Saúde

Fonte: Anvisa, 2007

DESCRIÇÃO

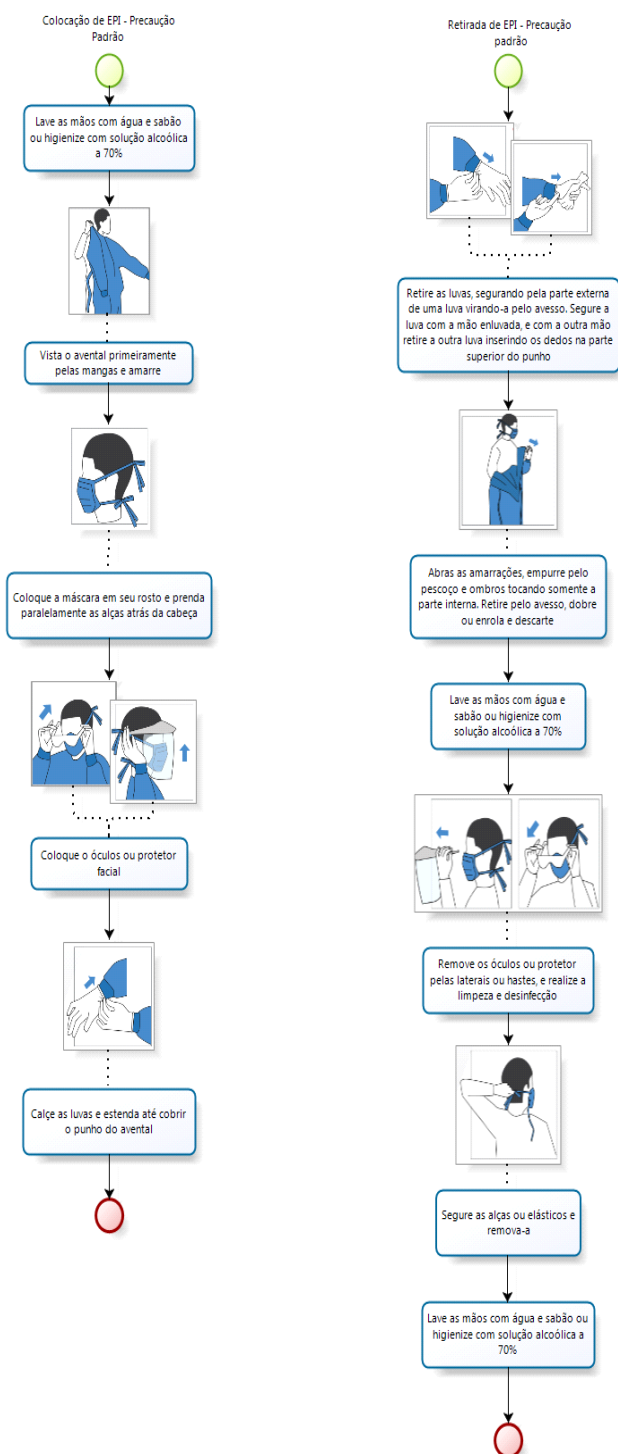
- **Higienizar as mãos:** lave com água e sabonete, antes e após o contato com o usuário (ver POP Rotina 23 – Higienização das Mãos) e após a remoção de EPIs (conforme Figura 02).
- **Avental:** use avental descartável, de manga longa, em toda manipulação do usuário, de cateteres e de sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies do leito e próximas ao leito.
 - Coloque-os imediatamente antes do contato com usuário ou com as superfícies e retire-os logo após o uso higienizando as mãos em seguida;
 - Certificar-se que o tronco esteja totalmente coberto, incluindo braços e punhos;
 - Vista o avental com a abertura para trás.
- **Óculos e Protetor Facial:** use óculos e protetor facial quando houver risco de respingos ou contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

Figura 02 – Colocação e retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI)



Fonte: Cofen, 2020

- **Máscara:** use máscara quando houver risco de respingos ou contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz.
 - Não utilizar máscara de tecido durante o turno de trabalho, sob nenhuma circunstância;
 - Não reutilize máscaras descartáveis;
 - Troque de máscara quando estiver úmida ou com sujidade aparente;
 - Não toque na frente da máscara durante o uso.

- **Luvax:** use luvas em toda manipulação do usuário, de cateteres e de sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do contato com usuário ou com as superfícies e retire-os logo após o uso higienizando as mãos em seguida;
 - Sempre que possível, escolha o tamanho de luva adequado para você;
 - Retire anéis, pulseiras ou outras joias de suas mãos. Isso pode danificar as luvas ou dificultar o processo de vesti-las;
 - Verifique a integridade das luvas cuidadosamente, se notar rasgos ou outros problemas visíveis, retire-as, lave novamente as mãos e vista luvas novas;
 - Não tocar superfícies e materiais não relacionados a assistência durante o uso de luvas;
 - O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos.
- **Calçados fechados:** sempre utilize calçados fechados durante o expediente de trabalho.

Observações:

- Exceto pela máscara, remova o EPI dentro, ou próximo à saída do quarto ou unidade do paciente. Remova a máscara somente após deixar o quarto do paciente e fechar a porta;
- Caixa perfuro cortante: descarte seringas, agulhas, lâminas e objetos cortos contusos, sem desconectá-las ou reencapá-las;
- Faz-se necessária a utilização de calça ou roupa que cubra as pernas, para proteção contra respingos, resíduos;
- Os instrumentais utilizados para o exame físico (estetoscópio, termômetro, etc), devem ser de uso exclusivo do paciente, higienizados sempre após uso com álcool 70%;
- Realize desinfecção concorrente ou, quando necessário terminal, conforme rotina de limpeza e desinfecção de superfícies (POP Rotina nº 36 – Limpeza e Desinfecção de Superfície);
- Desinfecção dos óculos e protetor facial (EPI): após o uso deve ser lavado com água e sabão, não pode ser substituído pelos óculos para correção da visão, com indicação oftálmica, devem ser associados durante o atendimento. No caso da não adaptação dos óculos de correção com os óculos de proteção, preferir o uso do protetor facial;
- Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIs;
- Não acumular materiais dentro dos quartos ou à beira do leito, pois esses terão que ser descartados após a saída do paciente;
- Realize desinfecção concorrente ou, quando necessário terminal, conforme POP Rotina nº 36 – Limpeza e desinfecção de superfície.

Referências

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. **Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020**. Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Brasília – SC: 2020.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Segurança do Paciente: Higienização das mãos**. Brasília – DF: 2020. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/paciente_hig_maos.pdf>. Acessado em: 17 de março de 2020.
3. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Cartaz Precauções**. Brasília – DF: 2007. 21/11/2007. Disponível em: <<http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/publicacoes.htm>>. Acessado em: 17 de março de 2020.
4. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Covid-19. **Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIs)**. São Paulo – SP: 2020.
5. World Health Organization (WHO). **Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (Covid-19)**: Interim guidance. 27 Feb. 2020.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2020 Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil 2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2

Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2020	Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil	
03	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Inclusão e atualização do texto; • Inclusão da figura 2; • Inclusão do quadro de observações.

